

IDENTIFICACIÓN

Apellido y Nombre:	ADER MANUEL	Número de documento:	45683086	Estado Civil:	
Tipo de documento:	D.N.I.	Edad de Atención:	22 años 0 meses	Sexo:	Masculino
Fecha de nacimiento:	26/04/2004	Dirección de domicilio:	AV. CABILDO 645 5° A	Teléfono domicilio:	1149865834
Lugar de residencia:	CABA	Parentesco:	Madre	Teléfono acompañante:	1149865834
Acompañante:	mejalelaty alejandra	Plan:	CELESTE	Numero de afiliado:	10097779003
Aseguradora:	MEDICUS	Episodio:	44635260	Clase de episodio:	Internados
Lugar de Atención:	HB Central				

Fecha Ingreso: 11/05/2026

Fecha Egreso: 12/05/2026

Epicrisis de egreso hospitalario

Condición de Egreso: Domicilio sin At. Domiciliaria

Antecedentes personales:
HEMATOLOGÍA

22 años

Diagnóstico actual:

Síndrome mielodisplásico / leucemia mieloide aguda (SMD/LMA) según clasificación ICC 2022

SMD con exceso de blastos tipo II según clasificación WHO 2022

Recaída temprana post-trasplante alogénico haploidentico, como LMA secundaria a SMD (38% de blastos)

◆Historia oncohematológica

Diagnóstico inicial: Mayo 2025

SMD en paciente joven

Clasificación ICC: SMD/LMA

Clasificación WHO: SMD con exceso de blastos tipo II

Clasif ICC: SMD/LMA Clasif WHO: EB tipo II

- Scores Pronósticos:

1. IPSS-Mol: RIESGO ALTO (Hb 6/RAN900/plaq10.000/CTG: cariotipo normal/WT1 mutado VAF 40,7%/blastos 9.3%, medulograma 12%)

2. IPSS-R: IPSS*R RIESGO ALTO

◆Tratamientos recibidos

>1ª línea (citorreducción): Azacitidina +Venetoclax → logra 1ª remisión completa (RC)

> 03/09/2025: Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos haploidentico

Indicación: estrategia con potencial curativo por enfermedad de alto riesgo

Evolución: sin EICH ni reactivación de CMV

Actualmente SMD Riesgo alto de LMA que recae post trasplante como LMA secundaria a SMD FLT3 positivo

◆Tratamiento de recaída

> Azacitidina + Venetoclax

Evaluación D28 (post ciclo 1): 18% blastos mieloides

Infiltración morfológica >20% → enfermedad refractaria

> Citarabina + Midostaurina

Control medular: 26% blastos mieloides → refractaria

> Requirió citorreducción por fase proliferativa:

Hidroxiurea + Citarabina

>27/04: Inicio de 3ª línea (off-label):

Azacitidina + Venetoclax + Gilteritinib

Estudios complementarios:

RMN 17/04: evolución radiológica favorable del proceso inflamatorio/infeccioso del conducto anal

Inicio esquema Esquema actual de tratamiento 3L (27/04/2026)

CTO 7/7: Azacitidina

Día 15/14: Venetoclax 200 mg (ajustado por interacción con isavuconazol)

Día 15/28: Gilteritinib 120 mg

IDENTIFICACIÓN

Apellido y Nombre: ADER MANUEL

Tipo de documento: D.N.I.

Número de documento: 45683086

Fecha de nacimiento: 26/04/2004

Lugar de atención: HB Central

Episodio: 44635260

Clase de episodio: Internados

Motivo de internación:

Estudios medulares

Resumen de Internación:

Cura internacion para realizacion de estduios medulares

Comentarios

Se brindan pautas de alarma y educación acorde a diagnostico

BARBIJO 3M.

USO DE PROTECTOR SOLAR F50 O MÁS UVA/UVB.

HIDRATACIÓN 2-2.5 LTS AL DIA (NO MATE).

PANTOPRAZOL 20 MG: TOMAR 1 COMPRIMIDO EN AYUNAS.

ACICLOVIR 400 MG: TOMAR 1 COMPRIMIDO CADA 12 HS (12-00 HS).

TMS FORTE (800/160 MG): TOMAR 1 COMPRIMIDO TRISEMANAL (LUNES-MIÉRCOLES-VIERNES)

MINOCICLINA 100 MG: TOMAR 1 COMPRIMIDO CADA 12 HRS

ISAVUCONAZOL 200 MG: TOMAR 1 COMPRIMIDO 12 HS.

PH LAGRIMAL: 1 GOTA EN CADA OJO CADA 4 HS

DULOXETINA 60 MG: TOMAR 1 COMPRIMIDO 8 AM.

CIPROFLOXACINA 500 MG: TOMAR 1 COMPRIMIDO CADA 12 HS

VENETOCLAX 100 MG: TOMAR 2 COMPRIMIDOS (200 MG) UNA VEZ AL DÍA, O AGUARDAR INDICACIÓN MÉDICA

GILTERITINIB 40 MG: TOMAR 3 COMPRIMIDOS (120 MG) POR DÍA HASTA EL DIA 28 DEL CICLO (24/05/26)

ZOLPIDEM 10 MG: SEGÚN NECESIDAD 1 COMPRIMIDO PARA DORMIR.

PAUTAS DE ALARMA: FIEBRE, DIARREA, VÓMITOS, INTOLERANCIA A LA VÍA ORAL, DETERIORO DEL ESTADO GENERAL, SIGNOS DE SANGRADOS, DOLOR ABDOMINAL.

Responsable: SUAREZ SANDOVAL LUIS MIGUEL

No. Matrícula MN176446

Servicio: HEMATOLOGIA



HOSPITAL BRITÁNICO
B.O. 176446
SUAREZ SANDOVAL LUIS MIGUEL